# GUIA DE SÍNTESE TÉCNICA: MANEJO CLÍNICO DO TABAGISMO NA APS

Apresentação exaustiva e integral do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT Tabagismo — Portaria Conjunta MS/INCA nº 10/2020), focado em Prática Ambulatorial, Atenção Primária, Avaliação Diagnóstica, Farmacoterapia e Abordagem Comportamental.

---

## 1. Epidemiologia, Impacto à Saúde e Marcos Regulatórios

O tabagismo é uma doença epidêmica crônica decorrente da dependência à nicotina, inserido na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) no grupo de transtornos mentais e de comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas (F17). A Organização Mundial da Saúde (OMS) o reconhece como a principal causa evitável de morbimortalidade prematura no mundo.

### Dados Epidemiológicos Globais e Nacionais:

• **Mortalidade Global:** O fumo é responsável por mais de 8 milhões de mortes anuais no mundo. A OMS atribui ao tabaco 71% das mortes por câncer de pulmão, 42% das Doenças Respiratórias Crônicas (DPOC/asma) e aproximadamente 10% das Doenças Cardiovasculares (DCV).

• **Prevalência no Brasil (PNS 2019 / INCA):** O Brasil possui cerca de 17 milhões de fumantes ativos. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2019) apontou prevalência de 12,6% de adultos fumantes (15,9% homens e 9,6% mulheres). O fumo causa cerca de 135 mil mortes anuais diretas no país.

• **Efetividade das Políticas do PNCT:** Desde 1989, com a consolidação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) gerido pelo Ministério da Saúde e INCA, o Brasil reduziu em 51% a prevalência de fumantes adultos (de 34,8% em 1989 para 12,6% em 2019).

### Marcos Legais e Governança (CQCT e MPOWER):

• **Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco (CQCT/OMS):** Primeiro tratado internacional de saúde pública, ratificado pelo Brasil em 2005 (Decreto 5.658/2006). Estabelece diretrizes globais para redução da oferta e da demanda.

• **Medidas MPOWER (OMS):** (M) Monitorar uso e políticas; (P) Proteger da poluição tabágica ambiental; (O) Oferecer ajuda para cessação no sistema de saúde; (W) Advertir sobre os perigos nos rótulos/embalagens; (E) Fazer cumprir proibições de publicidade, promoção e patrocínio; (R) Aumentar impostos e preços.

• **Lei de Ambientes 100% Livres de Fumaça (Lei 12.546/2011 / Decreto 8.262/2014):** Proíbe o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno (derivado ou não do tabaco) em locais fechados de uso coletivo em todo o território nacional, extinguindo os 'fumódromos'.

• **Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs / Vapes / E-cigarettes):** Dispositivos que aquecem e ejetam aerossóis contendo nicotina, solventes e aromatizantes. A RDC ANVISA nº 855/2024 (atualizando a RDC 46/2009) mantém a proibição estrita de comercialização, importação, manipulação, propaganda e transporte de DEFs no Brasil, alertando para o elevado risco de adicção precoce entre jovens e injúria pulmonar (EVALI).

### Carga de Doenças e Complicações Sistêmicas:

• **Neoplasias Malignas:** O fumo responde por 85–90% dos casos de câncer de pulmão e eleva de forma comprovada o risco de neoplasias de cavidade oral, laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, rim, bexiga e colo do útero.

• **Doenças Cardiovasculares e Vascular Periférica:** Aumenta de 2 a 4 vezes o risco de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e AVC. A nicotina e o monóxido de carbono (CO — afinidade 200x maior pela hemoglobina) induzem disfunção endotelial, aterogênese e estado pró-trombótico. É causa direta e essencial da **Tromboangeíte Obliterante (Doença de Buerger)**, vasculite oclusiva segmentar de pequenas/médias artérias em adultos jovens.

• **Doenças Respiratórias e Gestação:** Fator etiologicamente central para DPOC e enfisema. Na gestação, causa restrição de crescimento intrauterino (CIUR), baixo peso ao nascer, descolamento prematuro de placenta e eleva em 2-3 vezes o risco de **Síndrome da Morte Súbita do Recém-Nascido (SMSN)**.

• **Coinfecção Tuberculose-Tabagismo:** O tabagismo aumenta em 2,5 vezes o risco de infecção e adoecimento por tuberculose, piora a conversão bacteriológica de escarro e eleva a mortalidade.

## 2. Fisiopatologia da Nicotina e Dimensões da Dependência

A nicotina é uma substância psicoativa lipossolúvel que, quando inalada na fumaça do cigarro, é absorvida nos alvéolos pulmonares e atinge o cérebro em cerca de **7 a 10 segundos** (mais rápido que uma aplicação intravenosa). Possui meia-vida plasmática curta de aproximadamente 2 horas.

### Mecanismo Neurobiológico e Receptores Nicotínicos (nAChRs):

No Sistema Nervoso Central, a nicotina liga-se aos receptores nicotínicos de acetilcolina pentaméricos:

• **Receptores α4β2 (Alta Afinidade):** Concentrados no sistema mesolímbico dopaminérgico. Sua estimulação direta na área tegmentar ventral resulta na liberação imediata e maciça de **dopamina no nucleus accumbens**, promovendo sensação de prazer, alívio de ansiedade e reforço positivo. Modula também glutamato e GABA, aumentando temporariamente a atenção e o alerta.

• **Receptores α3β4 (Baixa Afinidade):** Localizados na habênula medial; ativados por doses elevadas de nicotina, desencadeando respostas aversivas (náuseas, mal-estar) como um mecanismo de freio neurobiológico.

• **Tolerância e Upregulation:** A exposição repetida à nicotina causa dessensibilização rápida dos receptores α4β2. Como compensação homeostática, o cérebro promove o aumento numérico dos receptores (*upregulation*). Quando os níveis de nicotina caem, esses receptores desocupados entram em estado de hiperexcitabilidade, disparando a Síndrome de Abstinência e o desejo compulsivo (*craving*).

> **A Tridimensionalidade da Dependência do Tabaco:**
> **1. Dependência Química/Física:** Neuroadaptação biológica mediada pela nicotina, manifestada pela Síndrome de Abstinência (irritabilidade, ansiedade, insônia, fome, tontura) e pela onda de fissura (*craving*) que dura cerca de 5 minutos.
> **2. Dependência Psicológica:** O cigarro utilizado como muleta emocional ou ferramenta de regulação do afeto (alívio do estresse, tristeza, solidão ou ansiedade).
> **3. Dependência Comportamental/Condicionamento:** Associação reflexa e rotineira do ato motor de fumar com gestos automáticos (fumar ao tomar café, após refeições, ao dirigir, ao ingerir álcool ou ao telefone).

### Classificação Estatística Internacional (CID-10 e DSM-5):

No CID-10, o tabagismo enquadra-se nas categorias: **F17.1** (uso nocivo), **F17.2** (síndrome de dependência de fumo) e **F17.3** (síndrome de abstinência de fumo). No **DSM-5 (Transtorno por Uso de Tabaco)**, o diagnóstico é estabelecido pela presença de pelo menos 2 de 11 critérios em um período de 12 meses, classificado em leve (2–3 critérios), moderado (4–5) e grave (≥ 6 critérios).

## 3. Avaliação Clínica na APS e Instrumentos de Medida

A avaliação do tabagista na Atenção Primária não requer exames complementares para o diagnóstico da dependência, baseando-se na anamnese estruturada e no histórico tabágico.

### Cálculo da Carga Tabágica (Maços-Ano):

Mede a exposição cumulativa ao tabaco ao longo da vida através da fórmula:

> **Fórmula da Carga Tabágica:**
> **Maços-Ano = (Número de cigarros fumados por dia / 20) × Anos de fumo**
> *Exemplo Prático:* Indivíduo que fuma 30 cigarros por dia há 25 anos:
> Maços-Ano = (30 / 20) × 25 = 1,5 × 25 = **37,5 maços-ano**. Carga ≥ 20 maços-ano é critério de alto risco para neoplasias e rastreamento de câncer de pulmão por Tomografia de Baixa Dose em pessoas entre 50–80 anos.

### Teste de Fagerström para Dependência de Nicotina (Quadro Oficial PCDT):

Questionário validado composto por 6 perguntas pontuadas de 0 a 10 para mensurar o grau de dependência física:

| Pergunta | Respostas Possíveis | Pontuação |
|---|---|---|
| 1. Quanto tempo após acordar você fuma seu 1º cigarro? | Nos primeiros 5 minutos<br>De 6 a 30 minutos<br>De 31 a 60 minutos<br>Após 60 minutos | 3<br>2<br>1<br>0 |
| 2. Você acha difícil não fumar em locais proibidos? | Sim<br>Não | 1<br>0 |
| 3. Qual o cigarro do dia que lhe traz mais satisfação? | O 1º da manhã<br>Qualquer outro | 1<br>0 |
| 4. Quantos cigarros você fuma por dia? | 10 ou menos<br>11 a 20<br>21 a 30<br>31 ou mais | 0<br>1<br>2<br>3 |
| 5. Você fuma mais frequentemente pela manhã? | Sim<br>Não | 1<br>0 |

| Pergunta | Respostas Possíveis | Pontuação |
|---|---|---|
| 6. Você fuma mesmo doente, quando acamado? | Sim<br>Não | 1<br>0 |

### Estratificação e Interpretação do Escore de Fagerström:

• **0 a 2 pontos (Muito Baixa):** Abordagem breve. Sem indicação formal de medicação de rotina.

• **3 a 4 pontos (Baixa):** Abordagem breve + considerar forma oral de resgate (goma/pastilha) isolada.

• **5 pontos (Média): Limiar para indicação de Farmacoterapia no SUS.** Recomenda-se TRN combinada ou Bupropiona associada à TCC.

• **6 a 7 pontos (Elevada) / 8 a 10 pontos (Muito Elevada):** Dependência física alta. Indicado fortemente o uso de TRN Combinada (Adesivo + Goma/Pastilha) ou Bupropiona + TRN de resgate.

• **Preditores Isolados Centrais:** A pergunta 1 (tempo para o 1º cigarro ≤ 30 min) é o melhor preditor biológico isolado da intensidade da dependência e dos sintomas de abstinência.

## 4. Abordagem Não Medicamentosa e Terapia Comportamental

O pilar fundamental da cessação tabágica na Atenção Primária é a **Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)** e a **Entrevista Motivacional**, que buscam reestruturar crenças aditivas e ensinar habilidades para enfrentar gatilhos.

### Modalidades de Abordagem Clínica na APS:

• **Abordagem Mínima / Breve (PAAP):** Duração de 3 a 5 minutos, realizada rotineiramente por todos os profissionais de saúde em qualquer atendimento de rotina. Passos: **P**erguntar sobre o fumo, **A**valiar motivação e dependência, **A**conselhar a parar de forma enfática e personalizada, e **P**reparar o paciente ou encaminhar.

• **Abordagem Intensiva / Estruturada (PAAPA):** Realizada por profissionais capacitados em consultas individuais ou em grupo na UBS. Passos: **P**erguntar, **A**valiar, **A**conselhar, **P**reparar e **A**companhar.

• **Estrutura do Grupo do PNCT / INCA:** Composto por 4 sessões semanais consecutivas de 90 minutos no primeiro mês (fase intensiva), seguidas de 2 sessões quinzenais no segundo mês e encontros mensais de manutenção até completar 12 meses.
*Sessão 1:* Entender por que se fuma e como afetou a saúde;
*Sessão 2:* Os primeiros dias sem fumar (definição do 'Dia D' e manejo da abstinência);
*Sessão 3:* Como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar (manejo do estresse, peso e álcool);
*Sessão 4:* Benefícios a longo prazo e prevenção de recaídas.

### Estágios Motivacionais (Prochaska e DiClemente) e Intervenção:

| Estágio Motivacional | Características do Paciente | Conduta e Ferramenta Recomendada |
|---|---|---|
| Pré-contemplação | Não considera parar nos próximos 6 meses. Defensivo ou desmoralizado. | Abordagem dos 5 R's (Relevância, Riscos, Recompensas, Roadblocks/Obstáculos e Repetição). Não confrontar. |

| Estágio Motivacional | Características do Paciente | Conduta e Ferramenta Recomendada |
|---|---|---|
| Contemplação | Reconhece o problema e pensa em parar nos próximos 6 meses, mas vivencia ambivalência. | Entrevista Motivacional. Aplicação da Balança Decisional (prós e contras) e Réguas de Prontidão. |
| Preparação | Tomou a decisão e planeja parar nos próximos 30 dias. | Definição do 'Dia D'. Planejamento prático, escolha do método (abrupto ou gradual) e suporte farmacológico. |
| Ação | Interrompeu o fumo há menos de 6 meses. | Suporte no manejo da Síndrome de Abstinência e fissura. Acompanhamento frequente. |
| Manutenção | Abstêmios há mais de 6 meses. | Prevenção sistemática de recaídas, controle de gatilhos e reforço dos ganhos de saúde. |

### Manejo Prático da Fissura (Craving):

Explicar ao paciente que a fissura é um impulso neuroquímico transitório que atinge o pico e **desaparece em cerca de 5 minutos**. Ensinar a regra dos 4 passos: **1)** Beber um copo de água gelada em pequenos goles; **2)** Realizar respiração profunda e diafragmática; **3)** Mudar de ambiente ou focar em uma tarefa manual (distração ativa); **4)** Usar a medicação de resgate rápida (goma/pastilha) se prescrita.

## 5. Tratamento Farmacológico no SUS (PCDT 2020)

A farmacoterapia do tabagismo visa aliviar os sintomas da Síndrome de Abstinência física. **Jamais deve ser prescrita isoladamente**, devendo sempre ser combinada à TCC/Aconselhamento Estruturado.

**Critérios formais para indicação de medicamentos no SUS:** Fumantes de ≥ 20 cigarros/dia; ou Teste de Fagerström ≥ 5; ou consumo do 1º cigarro até 30 minutos após acordar fumando ≥ 10 cig/dia; ou falha em tentativas anteriores apenas com TCC por abstinência severa.

### 1. Terapia de Reposição de Nicotina Combinada (CTRN) — Padrão-Ouro do PCDT:

Combina uma forma de liberação lenta (adesivo transdérmico) para manter o nível basal de nicotina, com uma forma de liberação rápida (goma ou pastilha de 2mg) no resgate de picos imprevisíveis de fissura. Apresenta superioridade demonstrada em ensaios clínicos (RR 1,25 vs. monoterapia).

• **Adesivo Transdérmico (Liberação Lenta - 7mg, 14mg e 21mg):**
• *≤ 5 cig/dia:* Adesivo **não é indicado**. Usar apenas forma oral (goma/pastilha 2mg) no resgate (máx. 5/dia).
• *6 a 10 cig/dia:* Iniciar com adesivo de **7 mg/dia**.
• *11 a 19 cig/dia:* Iniciar com adesivo de **14 mg/dia**.
• *≥ 20 cig/dia:* Iniciar com adesivo de **21 mg/dia**.
• *Fumantes muito pesados (> 30-40 cig/dia):* O PCDT autoriza a associação de dois adesivos iniciais (21mg + 14mg ou 21mg + 21mg; dose máx 42mg/dia), reduzindo 7mg por semana.
• *Esquema de Desmame Padrão (12 Semanas):* Semanas 1 a 4: 21 mg/dia; Semanas 5 a 8: 14 mg/dia; Semanas 9 a 12: 7 mg/dia.
• *Instruções de Uso:* Aplicar ao acordar no 'Dia D' em pele limpa, seca e sem pelos (tronco ou braço). Alternar o local diariamente (rodízio). Se causar insônia ou sonhos vívidos, retirar o adesivo ao dormir (após 16h de uso).

• **Gomas e Pastilhas de Nicotina (Liberação Rápida - 2 mg):**
• *Técnica Correcta (Chew and Park):* Mascar a goma vagarosamente até sentir sabor forte ou formigamento na boca; em seguida, 'estacionar' a goma entre a bochecha e a gengiva por alguns minutos até o sabor diminuir. Repetir por 30 minutos.
• *Restrição Alimentar:* **Não ingerir alimentos ou bebidas ácidas (café, refrigerante, sucos) nos 15 minutos anteriores** ou durante o uso, pois acidificam o pH bucal e bloqueiam a absorção transmucosa da nicotina.
• *Limite no SUS:* Na CTRN, recomenda-se até 5 unidades/dia de 2mg. Em monoterapia, no máximo 15 unidades/dia de 2mg.

### 2. Cloridrato de Bupropiona (150 mg):

Antidepressivo atípico que atua como Inibidor da Recaptação de Noradrenalina e Dopamina (IRND) e antagonista de receptores nicotínicos. Eleva os níveis de dopamina no *nucleus accumbens*, reduzindo a compulsão central pelo fumo. **Sua eficácia na cessação é independente de ação antidepressiva.**

• **Posologia e Titulação:** Deve ser iniciada **1 a 2 semanas (7 a 14 dias) ANTES do 'Dia D'**:
• *Dias 1 a 3:* 150 mg pela manhã.
• *Dia 4 em diante (até 12 semanas):* 150 mg 2 vezes ao dia (com intervalo mínimo de **8 horas** entre as tomadas).
• *Prevenção de Insônia:* A segunda dose deve ser tomada impreterivelmente antes das 16h/18h.
• *Ajuste de Dose (Idosos ≥ 65 anos, Insuficiência Renal ou Hepática):* Manter a dose em **150 mg/dia em tomada única matinal**.

• **Contraindicações Absolutas da Bupropiona:** Diagnóstico ou histórico de **epilepsia, convulsões** ou convulsão febril na infância (risco de crise convulsiva de 1:1.000 na dose de 300mg/dia); diagnóstico atual ou prévio de **Bulimia ou Anorexia Nervosa**; tumor do SNC; traumatismo craniano grave; uso recente (últimos 15 dias) de Inibidores da Monoaminoxidase (IMAO); e síndrome de abstinência aguda de álcool ou benzodiazepínicos.

| Medicamento | Apresentação e Posologia | Contraindicações Principais | Efeitos Adversos Comuns |
|---|---|---|---|
| Adesivo de Nicotina | 7mg, 14mg e 21mg transdérmico. 1x/dia ao acordar no Dia D. Desmame em 12s. | IAM recente (< 15 dias), angina instável, arritmias graves, lesões dermatológicas ativas. | Eritema e prurido local (usar corticoide tópico no local após), insônia, sonhos vívidos. |
| Goma / Pastilha 2mg | 2mg de liberação rápida. Mascar e estacionar na bochecha. Na CTRN: máx 5/dia. | Lesões de mucosa bucal, úlcera péptica ativa, disfunção grave da ATM, prótese móvel. | Irritação de garganta, soluços, dispepsia, pirose, dor na mandíbula. |
| Bupropiona 150mg | Comp. lib. prolongada. D1-3: 150mg/dia; D4-84: 150mg 2x/dia (8/8h). Dia D no 8º dia. | **Epilepsia/convulsões, Bulimia, Anorexia, tumor SNC, uso recente de IMAO.** | Boca seca, insônia, cefaleia, tremor, taquicardia, náuseas. |

## 6. Manejo em Populações Especiais e Interações Medicamentosas

O tratamento do tabagismo em grupos específicos exige adaptações rigorosas de conduta para garantir eficácia e segurança:

• **Gestantes e Nutrizes:** A **primeira linha absoluta é a Abordagem Cognitivo-Comportamental Intensiva**. O uso de farmacoterapia (TRN e Bupropiona) **não é recomendado pelo PCDT/SUS** por falta de evidências definitivas de segurança fetal e risco de vasoconstricção placentária. Se houver falha grave com risco materno-fetal extremo, avalia-se individualmente o uso excepcional de TRN de ação curta (goma) em menor dose possível.

• **Cardiopatas Agudos vs. Crônicos:** A TRN e a Vareniclina são comprovadamente seguras em pacientes com Doença Cardiovascular Estável (Estudo EAGLES 2016). Porém, em eventos agudos recentes (**Infarto Agudo do Miocárdio < 2 semanas**, angina instável ou arritmias ventriculares graves), deve-se preferir a TCC isolada nas primeiras 2 semanas antes de introduzir TRN.

• **Pacientes Psiquiátricos e a Indução da Enzima CYP1A2:**
• *Mecanismo:* A fumaça do cigarro (hidrocarbonetos aromáticos) é um potente indutor da enzima hepática **CYP1A2**.
• *Impacto Clínico ao Parar de Fumar:* Ao interromper o fumo, a perda da indução enzimática faz com que os níveis sanguíneos de medicamentos metabolizados pela CYP1A2 **AUMENTEM significativamente**, podendo atingir níveis tóxicos.
• *Fármacos Afetados:* **Clozapina, Olanzapina, Teofilina e Haloperidol**. Ao prescrever cessação do fumo para pacientes em uso desses medicamentos, é obrigatório monitorar sinais de toxicidade e prever a redução de dose de tais antipsicóticos.

• **Adolescentes (< 18 anos):** O aconselhamento motivacional e TCC em grupo é a escolha terapêutica. A Bupropiona não é preconizada pelo PCDT para menores de 18 anos por escassez de dados de segurança.

• **Pacientes com Tuberculose:** O fumo piora o prognóstico e a cura da TB. Todos os pacientes com TB ativa devem receber tratamento para cessação simultâneo (TCC + TRN ou Bupropiona).

## 7. Casos Clínicos Práticos para Aplicação na APS

**Caso Clínico 1: Fumante Pesado com Alta Dependência e Manejo com CTRN**
*História:* Homem, 52 anos, motorista. Fuma 30 cigarros/dia há 30 anos (45 maços-ano). Fuma o 1º cigarro 5 minutos após acordar. Escore de Fagerström = 9 (Muito Alta). Tentativas prévias frustradas por ansiedade e irritabilidade intensa no 2º dia sem cigarro.
*Conduta na APS:* Diagnóstico de Dependência Grave. Indicada Terapia de Reposição de Nicotina Combinada (CTRN) + TCC em grupo. Prescrito Adesivo Transdérmico de Nicotina 21 mg/dia a partir do 'Dia D' (desmame em 12s: 4s 21mg  4s 14mg  4s 7mg) associado a Gomas de Nicotina 2 mg para resgate de fissura (até 5/dia). Orientada aplicação matinal do adesivo com rodízio e técnica *chew and park* para a goma sem bebidas ácidas. Paciente completou 12 semanas em abstinência total.

**Caso Clínico 2: Paciente Psiquiátrico em Uso de Clozapina e Ajuste da CYP1A2**
*História:* Mulher, 41 anos, com diagnóstico de Esquizofrenia refratária em uso de Clozapina 400 mg/dia. Fuma 25 cigarros/dia há 20 anos. Ingressa no grupo de tabagismo e escolhe o 'Dia D' com uso de Bupropiona 150mg 2x/dia.
*Conduta na APS:* A equipe articulou o cuidado com o CAPS de referência. Alerta para a indução da enzima CYP1A2 pela fumaça do cigarro: ao parar de fumar no 8º dia de bupropiona, a taxa de depuração hepática da clozapina caiu, elevando seus níveis plasmáticos. A dosagem de clozapina foi reduzida preventivamente para 250–300 mg/dia para evitar sedação profunda, salivação excessiva e risco de convulsão. A paciente manteve a cessação com segurança.

*Guia Técnico elaborado para integração ao Portfólio do Estudante e Profissional de Medicina de Família e Comunidade.*